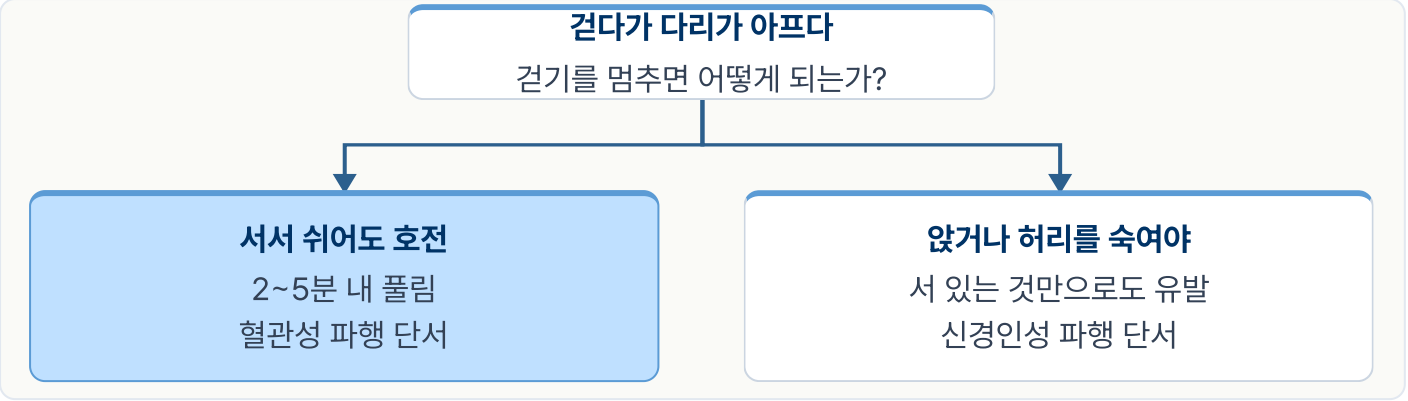
의료진 진료 카드 · ASL-012

하지 통증 · 멈추면 풀리는가?

감별 포인트는 쉬는 자세·증상의 재현성·통증 성격. 고령·당뇨에서는 두 질환이 공존할 수 있다.

연자 Q&A · 가장 먼저 묻는 쉬는 자세



연자 Q&A · 혈관성 파행(PAD)

위치·성격	종아리·허벅지·엉덩이 근육의 뻐근함·조임·피로. 저림은 드물다.
재현·유발	매번 비슷한 보행거리, 오르막·빠른 걸음에서 더 빨리 발생. 자세와 무관하며 서서 쉬면 2~5분 내 소실.
진찰	족배·후경골 맥박이 약하거나 소실. 본강의는 대퇴·슬와·발목 맥박을 좌우 비교하도록 설명.

연자 Q&A · 신경인성 파행

위치·성격	허리에서 다리로 내려오는 저림·당김·화끈거림·힘빠짐과 감각 증상.
자세·거리	발생 거리가 날마다 달라짐. 서 있기만 해도 발생하고 서서 쉬면 지속, 앉거나 허리를 숙이면 호전. 내리막에 심하고 자전거·카트 밀기는 잘 견딤.
진찰	족부 맥박은 정상일 수 있다. 척추 질환이 있어도 위험인자가 많으면 ABI로 동반 PAD를 확인.

연자 Q&A: 애매하면 ABI. 안정 ABI 0.9~1.4를 정상 범위로 설명했지만 전형적 파행이 지속되면 운동 후 ABI를 의뢰한다. 상처·휴식기 통증은 결과와 무관하게 바로 의뢰한다.

의료진 진료 카드 · ASL-012

파행·경련·냉감 · 검사 선택

전형적 파행을 수면 중 쥐·양측 냉감과 구분하고, 위험인자와 맥박에 따라 혈관검사를 연결한다.

연자 Q&A · 파행과 다른 증상

수면 중 종아리 쥐

갑자기 근육이 뭉치는 경련은 PAD와 직접 연관이 낮다. 탈수·K/Mg/Ca 이상·이뇨제/스타틴·신경병증·정맥부전·요추질환을 고려.

대칭성 냉감만 있음

파행·상처·색 변화 없이 양측 대칭이고 족부 맥박이 정상이면 PAD 가능성은 낮다. 레이노·갑상선저하·빈혈·자율신경·소섬유 신경병증 등을 고려.

연자 Q&A · 검사 흐름

ABI를 선택	편측 냉감, 족부 맥박 약화·소실, ≥65세, 당뇨·흡연·CKD·관상동맥/경동맥 죽상경화 병력. 등산 시 일정 거리·오르막에서 재현되는 종아리 통증도 평가.
냉감의 기본 평가	당뇨·음주·갑상선·B12 결핍 위험·항암제 등 병력. 맥박·온도·색·모발·부종·정맥류·단일섬유/진동감각, 혈당·HbA1c·TSH·CBC·B12·신기능.
추가 혈관검사	전형적 파행 + 정상 안정 ABI는 운동 ABI. ABI >1.4이면 TBI·초음파, ABI <0.9이면 병변 범위 추가 평가를 의뢰한다는 Q&A 답변.

본강의 · 해부학적 통증 위치

서혜부 위쪽	총장골·외장골동맥 협착은 엉덩이 통증으로 나타날 수 있다.
서혜부 아래쪽	대퇴동맥 이하 병변은 종아리 통증으로 나타날 수 있다. 대퇴·슬와·족배·후경골 맥박을 비교하며 협착 수준을 가늠한다.

연자 Q&A: 수면 중 경련은 원인 교정·취침 전 스트레칭·수분·약물 검토·전해질 교정이 우선. 퀴닌은 권하지 않고 Mg는 결핍 시 보충. 비특이 냉감만으로 항혈소판제·실로스타졸을 시작하지 않는다고 답변했다.